

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090727-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: MANUEL JOAQUIM MOREIRA CARNEIRO E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

MEDIDA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA - AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER A MEDIDA DE URGÊNCIA e de a ela NEGAR PROVIMENTO, para manter a decisão da origem. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5090727-08.2024.4.02.5101

510015322425 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5090727-08.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: MANUEL JOAQUIM MOREIRA CARNEIRO E OUTRO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro nos autos principais nº 5081957-26.2024.4.02.5101 (Ev. 3) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, solicitada pela autora, para determinar aos réus o agendamento de cirurgia de artroplastia total de quadril.

Parecer do NAT em Ev. 6.

Na decisão do Evento 8 destes autos, foi negado o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo recorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos e a realização de exames às pessoas que não tenham condições financeiras para o custeio.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no

sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Deste entendimento não destoa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DA LEI N. 1.533/51. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA 83/STF.

1. Não merece prosperar o recurso quanto à afronta ao art. 1º da Lei 1.533/51. O fundamento da inexistência da demonstração do direito líquido e certo não é apropriado em recurso especial, visto que demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Qualquer um dos entes federativos - União, estados, Distrito Federal e municípios - tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Agravo regimental improvido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 609.204/CE, Rel. Min. Humberto Martins, julg. de 16/12/2014, DJe de 19/12/2014)

Ao que se colhe do laudo médico de Ev. 1.2, fl. 14 dos autos originários, emitido em 11/09/2024, o autor foi diagnosticado com coxartrose avançada à esquerda e leve à direita, estando em acompanhamento ambulatorial no Hospital Federal do Andaraí, já inserido na fila de espera para realização de cirurgia. Segundo parecer da Câmara de Resolução de Litígios em Saúde (CRLS) de EV. 1.2, fls. 17/19, informa-se consulta para Ambulatório 1ª vez em Ortopedia - Quadril (Adulto) agendada em 27/10/2023 no referido Hospital, com situação de chegada confirmada.

Em parecer de Ev. 6, o Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (NAT) informa que a cirurgia de artroplastia solicitada está indicada para o quadro clínico da parte autora e está coberta pelo SUS. Informa também que o Hospital Federal do Andaraí integra a Rede de Traumatologia e Ortopedia de Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, é habilitado a realizar a cirurgia de que o autor necessita.

Porém, há outras pessoas na fila e não se tem notícia da gravidade do quadro clínico dos outros pacientes.

Constata-se, portanto, que o autor vem recebendo o devido atendimento em hospital integrante da Rede de Traumatologia e Ortopedia de Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro, bem como foi regularmente inserido em fila cirúrgica. Além disso, no único laudo médico emitido por ortopedista, não há indicação de que o quadro do autor demande intervenção urgente.

Não há dúvida que a parte autora aguarda há alguns meses para realizar a cirurgia de que necessita, nem se ignora que geralmente há uma lentidão no andamento da fila.

Contudo, deve-se ter em mente que a Administração Pública adota critérios razoáveis ao estabelecer a ordem da fila de espera para consultas, exames, procedimentos e cirurgias, no âmbito do SUS, sendo inviável menosprezar tais critérios com o intuito de satisfazer a demanda de uma única pessoa, em detrimento de toda a coletividade, criando, assim, uma situação de desigualdade em relação aos demais usuários do SUS, não cabendo ao Judiciário interferir nas prioridades estabelecidas pela Administração Pública em suas políticas públicas que busquem garantir o regular atendimento na rede de saúde.

Repise-se que o acolhimento da pretensão autoral implicaria violação ao princípio da isonomia, sem que haja um motivo apto a justificar uma diferenciação em relação às demais pessoas que, assim como a parte autora, sofrem da mesma enfermidade (enfrentando situações de igual ou mesmo maior gravidade) e que também possuem indicação para a realização da consulta há anos.

Antecipar o procedimento do autor, na prática, significa desmarcar ou, ao menos, adiar para data posterior a cirurgia já marcada de outro administrado (às vezes com quadro clínico de igual ou maior gravidade), que vem aguardando pacientemente na fila, para inserir quem se valeu do provimento judicial.

Dessa forma, não se pode ignorar que, excetuados os casos de risco de morte ou extrema urgência (que não é o caso do autor, como visto), deve ser observada a fila de espera, assegurando-se o tratamento isonômico entre os usuários do sistema público de saúde.

Assim, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, ausente o risco iminente para a vida da parte autora, há que ser mantida a decisão do JEF.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER A MEDIDA DE URGÊNCIA** e de a ela **NEGAR PROVIMENTO**, para manter a decisão da origem. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.